

Diagnóstico diferencial con trastornos afectivos y orgánicos

1. Introducción y relevancia clínica

El diagnóstico de psicosis es una de las tareas más complejas y críticas en psiquiatría, dado que **los síntomas psicóticos (delirios, alucinaciones, desorganización)** pueden presentarse en múltiples trastornos: **esquizofrenia, trastornos afectivos graves, consumo de sustancias, enfermedades neurológicas o metabólicas**.

Distinguir entre estas causas tiene enormes implicancias terapéuticas:

- La esquizofrenia requiere tratamiento antipsicótico prolongado.
- Las psicosis afectivas se tratan con estabilizadores del ánimo o antidepresivos más antipsicóticos.
- Las psicosis orgánicas pueden ser reversibles si se identifica y corrige la causa subyacente.

□ En el **EUNACOM**, las preguntas sobre este tema suelen centrarse en:

- Diferencias entre esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo o bipolar con psicosis.
- Criterios clínicos para identificar psicosis por sustancias o delirium.
- Importancia del insight, curso temporal y relación con el ánimo.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Concepto de psicosis

Se define como una **pérdida del juicio de realidad**, donde el individuo no puede distinguir lo que es real de lo que no lo es.

Esto se manifiesta clínicamente con:

- **Delirios** (creencias falsas y fijas).
- **Alucinaciones** (percepciones sin estímulo externo).

- **Pensamiento o conducta desorganizada.**

El desafío clínico radica en determinar **si la psicosis es primaria (esquizofrenia) o secundaria (afectiva u orgánica)**.

2.2. Mecanismos neurobiológicos comunes

Aunque las vías dopaminérgicas están implicadas en la mayoría de las psicosis, su origen varía:

- **Esquizofrenia:** disfunción dopaminérgica intrínseca del sistema mesolímbico y mesocortical.
 - **Trastorno bipolar:** alteraciones dopaminérgicas y glutamatérgicas moduladas por el ánimo.
 - **Psicosis orgánicas:** exceso o déficit de neurotransmisores por lesiones cerebrales, fármacos o tóxicos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Para diferenciar entre los distintos tipos de psicosis, es útil considerar cuatro ejes clínicos:

Eje	Pregunta clave
Temporalidad	¿El cuadro es agudo, episódico o crónico?
Relación con el ánimo	¿Los síntomas psicóticos ocurren solo durante episodios afectivos?
Insight	¿El paciente reconoce o duda de la veracidad de sus experiencias?

Etiología médica o tóxica

¿Hay evidencia de enfermedad neurológica, metabólica o consumo de sustancias?

3.1. Esquizofrenia

- **Curso:** crónico (>6 meses).
- **Síntomas:** delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, síntomas negativos.
- **Afectividad:** discordante o inapropiada (ej. ríe al hablar de temas tristes).
- **Insight:** pobre o ausente.
- **Inicio:** insidioso, con deterioro progresivo del funcionamiento.
- **Relación con el ánimo:** síntomas psicóticos predominan, independientemente del ánimo.

Ejemplo: paciente que cree ser perseguido por vecinos sin estar deprimido ni exaltado.

3.2. Trastorno esquizoafectivo

- **Síntomas psicóticos y afectivos coexistentes** (depresión o manía).
- **Criterio esencial DSM-5:**
 - Periodos con **síntomas psicóticos ≥2 semanas sin síntomas afectivos**.
 - Pero también periodos donde ambos coinciden.
- **Curso:** episódico con recuperación parcial.

Ejemplo: paciente con delirios persecutorios durante una depresión profunda, que luego mejora y mantiene algunos síntomas psicóticos residuales.

3.3. Trastorno bipolar con síntomas psicóticos

- **Psicosis ocurre exclusivamente durante episodios afectivos** (manía o depresión).
- **Delirios y alucinaciones congruentes con el ánimo.**
 - En manía: megalomanía (“soy elegido por Dios”).
 - En depresión: culpa o ruina (“mi cuerpo está podrido”).
- **Insight:** suele recuperarse tras resolución del episodio.
- **Curso:** episódico, con recuperación total entre crisis.

Ejemplo: paciente con ánimo exaltado, fuga de ideas, y delirio de grandeza (“soy un genio científico”).

3.4. Trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos

- Psicosis **solo durante episodios depresivos graves.**
- **Delirios congruentes con el ánimo:** culpa, ruina, castigo, enfermedad terminal.
- **Afecto:** congruente (tristeza, desesperanza).
- **Insight:** parcialmente conservado.
- **Riesgo alto de suicidio.**

Ejemplo: “He pecado y debo morir; Dios me castigará con cáncer”.

3.5. Psicosis breve reactiva

- **Duración:** <1 mes.
- **Desencadenante claro:** estrés agudo (duelo, trauma, catástrofe).
- **Síntomas:** delirios o alucinaciones transitorios.
- **Recuperación completa** tras el evento.

Ejemplo: mujer que, tras terremoto, cree oír voces de sus familiares fallecidos, se recupera en días.

3.6. Psicosis inducida por sustancias

- **Historia clara de consumo:** cannabis, cocaína, anfetaminas, LSD, alcohol, fenciclidina.
- **Inicio:** minutos a horas tras consumo.
- **Curso:** autolimitado (horas a días) si cesa el uso.
- **Síntomas:** delirios paranoides, alucinaciones visuales o táctiles (insectos, luces).
- **Insight:** puede ser parcial.

Ejemplo: consumidor de cocaína que siente “bichos caminando por su piel”.

□ EUNACOM: la **presencia de alucinaciones visuales o táctiles** orienta más a **psicosis tóxica** que a esquizofrenia.

3.7. Psicosis orgánicas (secundarias a enfermedades médicas)

Son causadas por disfunción cerebral estructural o metabólica.

Causas comunes:

- **Neurológicas:** epilepsia del lóbulo temporal, tumores, accidente cerebrovascular.
- **Endocrinas/metabólicas:** hipotiroidismo, hipercalcemia, enfermedad de Cushing, deficiencia de B12.
- **Infecciosas:** neurosífilis, VIH, encefalitis.
- **Autoinmunes:** lupus eritematoso sistémico (psicosis lúpica).

Claves clínicas:

- Inicio agudo, fluctuante.
- Alteración de conciencia o atención (delirium).
- Síntomas visuales o somáticos prominentes.
- Focalidad neurológica o hallazgos sistémicos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación general ante un paciente con psicosis

Antes de etiquetar como esquizofrenia, se debe **descartar causas médicas o tóxicas**.

Exámenes básicos sugeridos (MINSAL, 2021):

- Hemograma, electrolitos, glicemia, perfil hepático, función renal.
- TSH, T4 libre.
- Vitamina B12, ácido fólico.
- VDRL / VIH.
- Tóxicos en orina (cannabis, cocaína, anfetaminas).
- TC o RM cerebral si hay síntomas neurológicos, debut atípico o inicio tardío.
- EEG si se sospecha epilepsia temporal.

4.2. Pistas clínicas para orientar el diagnóstico

Característica	Esquizofrenia	Bipolar con psicosis	Orgánica / Sustancia
Inicio	Insidioso	Brusco	Súbito
Curso	Crónico	Episódico	Fluctuante
Afecto	Inapropiado	Congruente con ánimo	Variable
Insight	Nulo	Parcial	Parcial

Alucinaciones	Auditivas	Auditivas congruentes	Visuales / táctiles
Nivel de conciencia	Normal	Normal	Alterado (delirium)
Antecedente de consumo o enfermedad	No	No	Sí

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y consenso internacional)

5.1. Psicosis primaria (esquizofrenia, esquizoafectivo)

- **Antipsicóticos atípicos:** risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol.
 - **Clozapina** si resistente.
 - **Psicoeducación familiar y TCC.**
-

5.2. Psicosis afectiva

- **Depresión con psicosis:**
 - ISRS + antipsicótico atípico (sertralina + quetiapina, por ejemplo).
 - O **terapia electroconvulsiva (TEC)** si grave o con riesgo suicida.
 - **Bipolar con psicosis:**
 - Estabilizador del ánimo (litio, valproato, lamotrigina) + antipsicótico.
-

5.3. Psicosis orgánica o inducida por sustancias

- **Tratar causa subyacente:** suspender tóxicos, corregir electrolitos, tratar infección.
 - **Haloperidol o risperidona** en dosis bajas para síntomas transitorios.
 - Evitar benzodiacepinas salvo en delirium por abstinencia alcohólica.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Diagnóstico erróneo → tratamiento inadecuado o innecesario.
- Retardo en manejo de causas reversibles.
- Riesgo de suicidio o agitación psicótica.

Pronóstico

- **Psicosis afectivas:** mejor pronóstico, remiten entre episodios.
 - **Esquizofrenia:** curso crónico, pero estabilizable con tratamiento.
 - **Psicosis orgánicas o tóxicas:** remiten al corregir la causa.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. En **bipolar con psicosis**, los delirios son **congruentes con el ánimo**.
2. En **esquizofrenia**, los delirios son **incongruentes con el afecto**.
3. Las **alucinaciones visuales o táctiles** sugieren causa **orgánica o tóxica**.
4. En **psicosis orgánica**, la conciencia está **fluctuante o alterada**.

5. El **EEG** es clave para descartar epilepsia temporal.
 6. El **inicio súbito en adulto mayor** obliga a descartar causa médica.
 7. La **TEC** es muy eficaz en depresión psicótica y catatonia.
-



Errores comunes

- Diagnosticar esquizofrenia sin descartar hipotiroidismo o intoxicación.
 - Ignorar el consumo de cannabis o cocaína.
 - No evaluar síntomas afectivos en psicosis.
 - Tratar con antidepresivos una psicosis primaria.
 - No pedir neuroimagen en debut atípico (>40 años).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **síntomas psicóticos** pueden aparecer en múltiples trastornos; el diagnóstico correcto depende del contexto clínico.
2. En **esquizofrenia**, los síntomas son crónicos y no dependen del ánimo.
3. En **bipolar o depresión psicótica**, la psicosis es **congruente con el estado afectivo**.
4. La **psicosis inducida por sustancias** o **orgánica** suele tener **inicio agudo, conciencia alterada y alucinaciones visuales/táctiles**.
5. Siempre descartar **causas médicas y tóxicas** antes de diagnosticar esquizofrenia.
6. **EEG, tóxicos en orina y neuroimagen** son exámenes básicos en debut psicótico.
7. Un manejo adecuado mejora pronóstico y previene iatrogenia farmacológica.